Psicologia em Pauta

EDIÇÃO ESPECIAL

CIÊNCIA • SAÚDE • COMPORTAMENTO • VIDA REAL

Você disse ou só achou que disse?

Como diferenças de interpretação podem mudar a forma de se comunicar, aprender, trabalhar e se relacionar.



ERA ÓBVIO. PRA QUEM?

Neurodivergência, comunicação e o risco de esperar que o outro adivinhe o que você quis dizer.

Nem tudo é autismo.
Nem toda diferença é "frescura".

Diagnóstico responsável:
característica não é transtorno.

Quiz educativo:
o que você realmente comunicou?

Curadoria: Gabriel Batista - Neuropsicólogo | CRP 06/176184

ABERTURA

Você disse - ou só achou que disse?

A mesma frase pode chegar ao outro com um significado diferente daquele que você imaginou. Isso acontece por cultura, história de vida, idade, contexto, emoção e também por diferenças no modo de perceber pistas sociais e linguagem implícita.



O que está claro dentro da sua cabeça pode continuar invisível para o outro.

Por isso, esta edição não ensina "como identificar um neurodivergente". Ela ensina algo mais útil: como compreender diferenças sem transformar cada diferença em diagnóstico, e como falar com mais clareza sem perder gentileza.

ESTA REVISTA NÃO DIAGNOSTICA

Reconhecer-se em uma situação pode abrir uma pergunta. Não confirma TEA, TDAH ou outra condição.

ESTA REVISTA CONVIDA

Se algo desperta sofrimento, prejuízo ou dúvida persistente sobre seu desenvolvimento, vale procurar avaliação profissional.

Pensamento não vem com Wi-Fi. Na Análise do Comportamento, pensamentos e sentimentos podem ser descritos como eventos privados: existem, mas não ficam automaticamente disponíveis ao interlocutor.

Fontes: [6], [7], [12]

CONCEITO

O que é neurodivergência?

Neurodivergência é um termo amplo usado para falar de pessoas cujo funcionamento neurológico ou desenvolvimento se afasta do padrão considerado típico. O termo não é um diagnóstico do DSM ou da CID e não descreve uma única condição. [5][6]

Não é sobre ser melhor ou pior. É sobre reconhecer diferenças sem transformar diferença em defeito.

A comparação do destro e do canhoto ajuda a entender uma parte do problema: ambientes costumam ser planejados para a maioria. Quando a forma de funcionar de alguém é menos comum, pode haver esforço extra, barreiras e necessidade de adaptação.



PERCEPÇÃO

detalhes e contexto podem receber pesos diferentes

ATENÇÃO

o foco pode oscilar, hiperfocar ou exigir mais esforço

SENSORIAL

sons, luzes, cheiros e texturas podem ser vividos com outra intensidade

COMUNICAÇÃO

pistas implícitas e ironias podem não ter o mesmo significado para todos

Importante: uma abordagem de neurodiversidade pode coexistir com deficiência, sofrimento e necessidade de suporte. Respeitar identidade não significa negar dificuldades reais. [6]

Fontes: [5], [6]

RIGOR CLÍNICO

Característica não é diagnóstico.

Todo mundo pode se distrair, preferir rotina, se incomodar com barulho, não entender uma ironia ou ficar exausto socialmente. A avaliação clínica pergunta outra coisa: isso forma um padrão? Desde quando? Em quais contextos? Com que impacto? Há explicações alternativas? [1][2][3][4]



"Marquei cinco características. Então eu tenho?"
Não. Diagnóstico não funciona como bingo. Checklists e vídeos podem levantar perguntas, mas não substituem avaliação profissional.

TEA: O QUE O CRITÉRIO PROCURA

No TEA, o DSM-5-TR descreve diferenças persistentes na comunicação/interação social junto a padrões restritos ou repetitivos de comportamento, interesses ou sensorialidade. As características começam no período do desenvolvimento e precisam ter relevância clínica. [2][3]

TDAH: O QUE O CRITÉRIO PROCURA

No TDAH, considera-se um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade, presença de vários sintomas antes dos 12 anos, manifestação em mais de um contexto e impacto funcional, além de outras explicações possíveis. [4]

Identificação pode abrir uma pergunta. Diagnóstico é o processo que tenta respondê-la com método.

Fontes: [1], [2], [3], [4]

AVALIAÇÃO

Como se chega a um diagnóstico responsável?

Não existe uma única conversa, um único teste ou uma única imagem que conte toda a história. Uma avaliação responsável junta informações e verifica se elas formam um padrão coerente.



1. **Pergunta clínica**
   O que está acontecendo e o que a pessoa quer compreender?
2. **História de vida**
   Desenvolvimento, escola, relações, trabalho, saúde e mudanças ao longo do tempo.
3. **Contextos**
   Como as características aparecem em ambientes e situações diferentes?
4. **Métodos adequados**
   Entrevistas, anamnese, observação e instrumentos escolhidos para a finalidade.
5. **Diagnóstico diferencial**
   O que mais pode explicar essas dificuldades? Sono, saúde, emoções, uso de substâncias, outras condições?
6. **Devolutiva**
   O que os dados permitem concluir, quais são os limites e quais próximos passos fazem sentido?

No Brasil, avaliação psicológica é um processo estruturado. Quando houver testes psicológicos, a(o) psicóloga(o) deve verificar a condição de uso no SATEPSI e seguir os manuais técnicos aprovados. Testagem não é sinônimo de avaliação. [9]

Fontes: [9]

CRITÉRIO CHECKLIST

O manual ajuda o profissional. Não transforma o leitor em diagnosticador.

DSM-5-TR e CID-11 organizam descrições e critérios para aumentar consistência clínica e comunicação entre profissionais. A própria APA ressalta que os critérios do DSM são destinados a profissionais treinados, com julgamento clínico, e não ao uso diagnóstico pelo público geral. [1][5]

> “Tenho uma característica” não é igual a “preencho critérios diagnósticos”.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Uma mesma manifestação pode ter explicações diferentes. Esquecimento pode aparecer com privação de sono, ansiedade, depressão, uso de substâncias, condições clínicas ou TDAH. Evitar contato visual pode depender de cultura, ansiedade, personalidade, contexto ou TEA. O diagnóstico procura o conjunto e a trajetória, não um comportamento isolado.

POR QUE HISTÓRIA IMPORTA?

Condições do neurodesenvolvimento são avaliadas considerando desenvolvimento e funcionamento ao longo da vida. Em adultos, características podem ter passado despercebidas, sido compensadas ou ficado mais evidentes quando as demandas aumentaram. Isso não significa que a condição "começou" na vida adulta. [2][3][4]

O objetivo não é colecionar rótulos. É entender o que explica melhor o funcionamento da pessoa e quais apoios, adaptações ou tratamentos podem ajudar.

Fontes: [1], [2], [3], [4], [5]

FALAR CLARO TAMBÉM É CUIDAR

Indireta não vem com legenda.

Ser assertivo é dizer o que você precisa com clareza e respeito. Isso não serve apenas para pessoas neurodivergentes: ajuda em diferenças culturais, geracionais, familiares e profissionais.



COMO COSTUMAMOS FALAR	UMA FORMA MAIS CLARA
“Nossa, como a hora passou rápido...”	“Adorei sua companhia. Agora eu preciso descansar. Vamos marcar de novo?”
“Faz o que você quiser.”	“Eu fiquei chateado e quero conversar antes de você ir.”
“Você foi ótimo hoje!”	“A sua ajuda organizando a mesa me deixou mais tranquilo. Obrigado.”
“Quando puder, me manda.”	“Preciso disso hoje até as 16h. Se não der, me avise até as 14h.”

Gentileza não é fazer o outro adivinhar com delicadeza. É ajudá-lo a entender.

Fontes: [7], [8], [12]

TRÊS CENAS

A mesma frase muda quando o contexto muda.

Em casa, na escola e no trabalho, a pergunta é a mesma: o outro recebeu o que eu queria comunicar ou recebeu apenas as palavras que eu usei?



EM CASA / VISITAS

“Nossa, como a hora passou rápido...”

Pode ser apenas um comentário sobre o horário. Se você quer encerrar a visita, diga isso com carinho.

Mais claro: “Adorei que você veio. Agora eu preciso descansar. Vamos marcar de novo?”



NA ESCOLA

“Capricha mais.”

Quem já sabe o que precisa melhorar pode entender. Quem não sabe fica sem direção.

Mais claro: “Revise a ortografia e complete o último exercício. Se tiver dúvida, me chama.”



NO TRABALHO

“Quando puder, me manda.”

Sem prazo e sem prioridade, duas pessoas podem organizar o dia de maneiras incompatíveis.

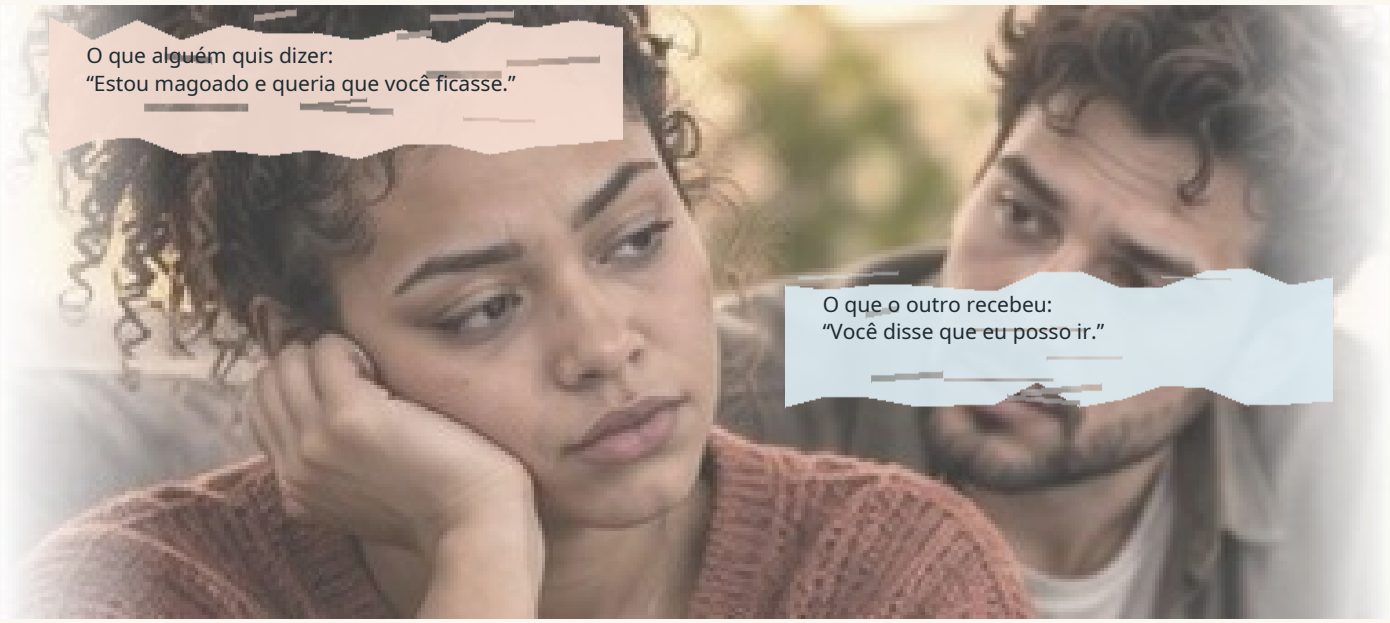
Mais claro: “Preciso disso hoje até as 16h. Se houver impedimento, me avise até as 14h.”

Fontes: Exemplos educativos; não descrevem uma reação única de pessoas neurodivergentes.

SE FOSSE COM VOCÊ?

“Faz o que quiser.” E se a outra pessoa fizer?

Às vezes uma pessoa tenta comunicar frustração por uma indireta; a outra recebe autorização literal. O problema pode estar menos em “quem está certo” e mais na diferença entre intenção e mensagem.



A hipótese do problema da dupla empatia propõe que alguns desencontros entre pessoas autistas e não autistas são recíprocos: pessoas com experiências e formas de comunicação diferentes podem interpretar mal umas às outras. É uma perspectiva de pesquisa, não um critério diagnóstico. [7][8]

Uma relação não fica menos espontânea porque você falou claramente. Às vezes fica apenas menos cansativa.

Fontes: [7], [8]

NEM TUDO É “FRESCURA”

O mesmo barulho pode ser só chato para você e muito difícil para outra pessoa.

Diferenças sensoriais podem aparecer no autismo e em outras condições, mas uma reação isolada a som, luz, cheiro ou textura não fecha diagnóstico. [2][3][5]



EM VEZ DE

“Deixa de frescura, já passou.”

TENTE

“Eu vi que esse barulho te incomodou bastante. Quer ir para um lugar mais quieto?”

Validar uma experiência não significa afirmar uma causa clínica. Você pode reconhecer o desconforto sem diagnosticar a pessoa.

Acolher não é diagnosticar.

Fontes: [2], [3], [5]

SEM PONTUAÇÃO DIAGNÓSTICA

O que você realmente disse?

Isto é um exercício de comunicação. Não existe placar, “resultado” ou interpretação clínica.

1 “Nossa, essa pia está ficando enorme...”

O que foi dito literalmente?

C) Há muita louça na pia. “Lave” ou “me ajude” podem ser intenções, mas não foram verbalizadas.

2 Você precisa de silêncio.

Qual frase pede isso com menos adivinhação?

“Preciso de dez minutos em silêncio, por favor.”

3 “Você foi incrível hoje!”

Como tornar o elogio mais claro?

Diga o comportamento: “Sua ajuda na reunião organizou minhas ideias.”

4 “Você nunca me chama.”

Como transformar crítica em pedido?

“Eu gosto de estar com você e queria que você também me convidasse às vezes.”

Pergunta-chave: o que estava claro dentro de você, mas nunca saiu em palavras?

Fontes: Exercício educativo; sem finalidade de triagem ou diagnóstico.

Material educativo. Não substitui avaliação profissional.

TROQUE DE LUGAR

Agora tente receber a mensagem como se não soubesse o que o outro quis dizer.

O objetivo não é decorar “como uma pessoa neurodivergente pensa”. É lembrar que ninguém tem acesso automático à sua subjetividade.

VISITA	“Nossa, como a hora passou rápido...”	Você entenderia como despedida ou apenas como comentário sobre o horário?
ESCOLA	“Capricha mais.”	Se você fosse aluno, saberia exatamente o que precisa mudar?
TRABALHO	“Quando puder.”	Existe prazo, prioridade ou consequência visível?
RELACIONAMENTO	“Faz o que quiser.”	É autorização, frustração ou pedido de proximidade? Se é importante, por que não dizer?

NÃO CONFUNDA

característica diagnóstico • identificação avaliação • objetividade grosseria • diferença defeito • acolhimento afirmar causa clínica

Fontes: [7], [8]

SE VOCÊ SE IDENTIFICOU

Curiosidade pode virar cuidado.

Se você se reconheceu em vários exemplos e isso traz sofrimento, prejuízo, conflitos frequentes ou dúvida persistente, vale procurar um profissional. Identificação não confirma diagnóstico, mas pode ser um bom motivo para conversar com alguém habilitado.



QUEM PODE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO E DO CUIDADO?

- Psicólogo(a) / neuropsicólogo(a): pode investigar aspectos emocionais, comportamentais, do desenvolvimento e, quando indicado, funções cognitivas e neuropsicológicas. [9][10]
- Psiquiatra, neurologista, pediatra ou outras especialidades médicas: podem avaliar aspectos clínicos conforme idade, hipótese e necessidade.
- Fonoaudiologia, terapia ocupacional e outras áreas: podem integrar o cuidado quando comunicação, sensorialidade, autonomia e participação cotidiana pedem avaliação específica.

E NO SUS?

A Atenção Primária à Saúde é a principal porta de entrada do SUS. Para investigação de TEA, o Ministério da Saúde orienta procurar a UBS mais próxima; conforme necessidade e rede local, pode haver encaminhamento para serviços especializados, como CAPSi, CER, policlínicas ou serviços de referência. A oferta varia entre municípios. [11][12]



CAMINHO POSSÍVEL

UBS acolhe e coordena

AVALIAÇÃO define necessidades

REDE encaminha quando indicado

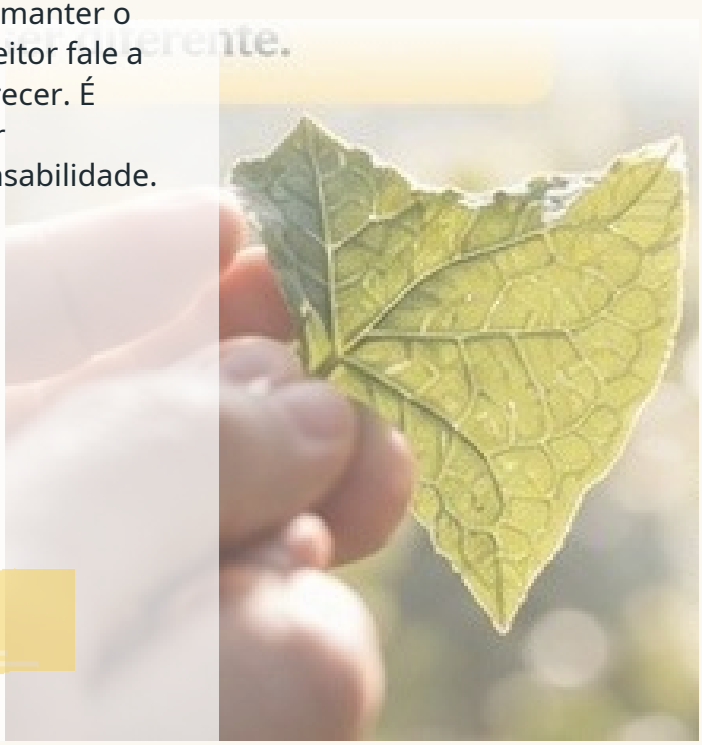
Fontes: [9], [10], [11], [12]

Material educativo. Não substitui avaliação profissional.

CURADORIA

Ciência precisa chegar às pessoas.

Esta edição foi construída para fazer uma ponte: manter o rigor de uma discussão clínica sem exigir que o leitor fale a língua da universidade. Simplificar não é empobrecer. É organizar o conhecimento para que ele possa ser compreendido, questionado e usado com responsabilidade.



Compreender não é diagnosticar.

Neurodiversidade pode ajudar a olhar para diferenças com menos estigma. O diagnóstico, quando necessário, ajuda a organizar hipóteses, reconhecer necessidades de suporte e planejar cuidado. Uma coisa não precisa apagar a outra.

Curadoria e texto
Gabriel Batista - Neuropsicólogo | CRP 06/176184
Psicologia em Pauta • Neuropsicologia aplicada à vida real

Regra de ouro desta edição: se você quer que o outro entenda algo importante, fale com clareza. E, se algo sobre seu funcionamento merece investigação, procure um profissional habilitado.

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS E INSTITUCIONAIS

Leitura responsável começa pela fonte.

Seleção de fontes utilizadas na curadoria. Documentos oficiais e literatura revisada por pares foram priorizados.

1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5-TR. 5. ed., text rev. Washington, DC: APA Publishing, 2022. Ver também as atualizações oficiais de critérios e texto publicadas pela APA em 2025.

2. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. What Is Autism Spectrum Disorder? Psychiatry.org, revisão médica jan. 2024.

3. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5-TR Fact Sheets: Autism Spectrum Disorder. Washington, DC: APA.

4. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Psychiatry.org. Acesso em 28 set. 2026.

5. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders. Geneva: WHO, 2024.

6. DWYER, Patrick. The Neurodiversity Approach(es): What Are They and What Do They Mean for Researchers? Human Development, v. 66, n. 2, p. 73-92, 2022. DOI: 10.1159/000523723.

7. MILTON, Damian E. M. On the ontological status of autism: the “double empathy problem”. Disability & Society, v. 27, n. 6, p. 883-887, 2012. DOI: 10.1080/09687599.2012.710008.

8. CHEANG, Rachael T. S. et al. Do you feel me? Autism, empathic accuracy and the double empathy problem. Autism, v. 29, n. 9, p. 2315-2327, 2025. DOI: 10.1177/13623613241252320.

9. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CFP nº 31/2022. Estabelece diretrizes para avaliação psicológica e regulamenta o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI. Brasília, DF: CFP, 2022.

10. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Manual Neuropsicologia: Ciência e Profissão. Brasília, DF: CFP, 2023. A Neuropsicologia é especialidade da Psicologia regulamentada, atualmente, pela Resolução CFP nº 23/2022.

11. BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção Primária. Brasília, DF. A APS é apresentada pelo Ministério da Saúde como principal porta de entrada do SUS. Acesso em 28 set. 2026.

12. BRASIL. Ministério da Saúde. Onde posso procurar diagnóstico para TEA no SUS? Saúde de A a Z - Autismo. Atualizado em 8 out. 2025. O primeiro passo indicado é procurar a UBS; encaminhamentos dependem da necessidade e da rede local.

13. SKINNER, B. F. About Behaviorism. New York: Knopf, 1974.

Critério editorial: fontes oficiais, normas profissionais e literatura revisada por pares. O material é educativo e não substitui manuais completos, avaliação clínica ou julgamento profissional.